



קבוצה	סימפטומימטי
מנגנון הפעולה	אדרנלין הוא הורמון ונוירוטרנסמיטור מבחינה כימית, אדרנלין הוא מונואמין שמיצור מחומצת האמינו טירוזין בבלוטת האדרנל שבכליה. אדרנלין פועל על קולטני α ו-β אדרנרגיים, והוא ה-α אגוניסט החזק ביותר. בהשפעה על β_1 תתקבל התכווצות חזקה יותר של שריר הלב, עלייה בלחץ הדם, עלייה בדופק ובתפוקת הלב. בהשפעה על β_2 תתקבל הרפיית השריר החלק בדופן הסמפונות והפחתת הפרשות ריריות. בהשפעה על α יתקבל כיווץ שריר חלק בדופן העורקיקים (עור, ריריות, כליות), עיכוב בשחרור ההיסטמין וכן הרחבה של כלי הדם בשרירי השלד.
פרמקוקינטיקה	מתן ב-I.V. תחילת ההשפעה בתוך 2 דקות. שיא ההשפעה לאחר 5 דקות. משך ההשפעה 5–10 דקות. מתן ב-S.C. תחילת ההשפעה בתוך 3–10 דקות. שיא ההשפעה לאחר 20 דקות. משך ההשפעה 20–30 דקות.
התוויות לשימוש	דום לב; תגובה אנפילקטית; סטרידור בילדים; התקף אסתמה; ברדיקרדיה; ירידה בפרפוזיה.
התוויות נגד	הפרעות קצב מהירות (טכיאריטמיות); IHD.
תופעות לוואי	כאבי ראש; בחילות; הקאות; טכיאריטמיות; אוטם שריר הלב; תחושת חרדה; פלפיטציות; הזעת יתרה.
מינון מבוגרים	דום לב – 1 mg כל 3–5 דקות (מתן ב-I.V / I.O). מתן ב-E.T – 3 mg מהולים ב-3–5 ml סליין. ברדיקרדיה / ירידה בפרפוזיה / ROSC 2–10 mcg/min ב-DRIP או 10–20 mcg ב-PUSH במנות חוזרות. אסתמה – 0.3 mg ב-S.C, 0.5 mg ב-I.M. אנפילקסיס תגובה קשה – 0.3–0.5 mg מתן ב-I.M, אפשר לחזור על המנה עד 3 פעמים בהפרש של 10 דקות בין המנות. מיקום הזרקה מועדף – שריר הירך. דום לב – 1 mg, מתן ב-I.V, כל 2 דקות.

מינון ילדים	דום לב, ברדיקרדיה – 0.01 mg/kg (מינון מקסימלי 1 mg). – מתן ב־E.T – 0.1 mg/kg מהולים ב־3-5 ml סליין. – בהחייאה יש לחזור על המינון כל 3-5 דקות. החייאת ילוד – מינון 0.01-0.03 mg/kg. תגובה אלרגית (אנפילקסיס) – תגובה קשה – 0.01 mg/kg, מתן ב־I.M (מינון מקסימלי 0.5 mg). - מיקום הזרקה מועדף – שריר הירך. – דום לב – 0.01 mg/kg (מינון מקסימלי 1 mg), כל 2 דקות. אסתמה 0.01 mg/kg, מתן ב־I.M / S.C (מינון מקסימלי 0.4 mg). סטרידור - מינון – 0.25-0.5 mg/kg (מינון מקסימלי – 5 mg בנפח – 5 ml) מתן ב־Inh.
צורות מתן במד"א	I.V / I.O / E.T / I.M / S.C / Inh
מופיע בפרוטוקול	<u>דום לב ונשימה במבוגר; דום לב בתינוקות ובילדים; הטיפול המיידי ביילוד; סטרידור בילדים; ברדיקרדיה במבוגר; ברדיקרדיה בילדים; התקף אסתמה במבוגר; התקף אסתמה בילדים; תגובה אלרגית (אנפילקסיס) מבוגר; ירידה בפרפוזיה (שלא על רקע טראומה); הטיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC)</u>